TEMA 11 · Atención domiciliaria. Epidemiología y vigilancia epidemiológica

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Atención domiciliaria, visita domiciliaria, coordinación, inmovilizados, paliativos e informe de continuidad de cuidados · Bloque B: Método epidemiológico, diseños, enfermedades transmisibles, RENAVE, EDO, SiVIRA y One Health

A1. Concepto, marco legal y objetivos

- **Atención domiciliaria**: actividades sanitarias y sociales en el domicilio para detectar, valorar y seguir los problemas de salud del individuo **y su familia**, potenciando su autonomía. Enfoque biopsicosocial, comunitario, continuidad y promoción de la autonomía.
- Marco: **Ley 14/1986** (AP como eje), **Ley 16/2003** y **RD 1030/2006** (cartera: atención **programada** a inmovilizados y **urgente** a demanda; promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliativos). En Murcia, la **Ley 3/2009** reconoce el derecho a ser atendido en casa; **Plan Integral de Cuidados Paliativos**.
- Objetivo general: mantener la salud y la calidad de vida en el entorno familiar, **evitar ingresos e institucionalizaciones innecesarias** y apoyar al cuidador. El **sujeto** de atención es el binomio **paciente + familia/cuidador**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **Inmovilizado** = **prevenir** complicaciones (UPP, respiratorias). **Terminal** = **controlar síntomas** y confort.

A2. La visita domiciliaria

- Actividad propia de la AP (accesibilidad, longitudinalidad). Programada o urgente; de valoración, seguimiento, educación, técnicas o coordinación. La enfermera es **"invitada"** en el domicilio.
- **Etapas**: **captación** → **valoración** → **planificación** → **ejecución** → **evaluación** → **registro** ("Con Valor Puedo Ejecutar Este Reto").
  - **Captación**: derivación de AP (la más frecuente), del hospital (enlace, gestora de casos), de servicios sociales o a petición de la familia (validada).
  - **Valoración integral**: clínica, funcional (Barthel), cognitiva (MEC, Pfeiffer), ánimo (**Yesavage**), riesgo de UPP (Norton, Braden) y caídas, y **social y familiar** (cuidador, vivienda, **Zarit**). **Revalorar al menos cada 6 meses** si está estable.
  - **Planificación**: NANDA-NOC-NIC, objetivos **SMART** consensuados con paciente y familia; plan de cuidados individualizado (o plan de atención integral).
  - **Ejecución**: técnicas, educación, prevención y apoyo psicosocial.
  - **Evaluación**: clínica, funcional, conocimientos, uso de recursos y **sobrecarga del cuidador**.
- **Registro**: en el SMS, mediante el **Modelo 313 (Valoración Integral de Enfermería)** en OMI-AP/Ágora, que obliga a cumplimentar las escalas.

Escala	Valora	Puntuación
Barthel	ABVD (10 actividades)	0-100; **a menos puntos, más dependencia** (los cortes intermedios varían según la fuente)
Lawton y Brody	AIVD	0-8
MEC de Lobo	Cognición	Deterioro < 24 (< 20 si bajo nivel cultural)
Pfeiffer	Cognición	Cuenta **errores**: 0-2 normal; 3-4 leve; ≥ 5 moderado/severo
Yesavage (15 ítems)	Depresión geriátrica	> 5 sospecha
Norton	Riesgo de UPP	5-20; ≤ 14 riesgo; ≤ 12 alto
Braden	Riesgo de UPP	6-23; ≤ 16 riesgo; ≤ 12 alto

Escala	Valora	Puntuación
Zarit	Sobrecarga del cuidador	22-110; < 47 no; 47-55 leve; > 55 intensa

CLAVE PARA RECORDAR

- En casi todas, menos puntos = peor. Excepciones: **Pfeiffer, Zarit y Yesavage** (más puntos = peor).

A3. Coordinación sociosanitaria

- El gran riesgo para el paciente crónico complejo es la **fragmentación** de la atención. Niveles de coordinación: **macro** (planes y acuerdos entre consejerías), **meso** (programas) y **micro** (atención directa).
- Instrumentos: **informe de continuidad de cuidados**, informe de alta, historia clínica compartida (OMI-AP/Selene) y comunicación directa. Figuras: comisiones sociosanitarias, **enfermera gestora de casos o de enlace** (coordina recursos; reduce urgencias e ingresos), **ESAD** y equipos de soporte de paliativos, y **trabajador social** (nexo con el **IMAS**: dependencia, teleasistencia).
- El **ESAD apoya y asesora**, pero **nunca sustituye** al equipo de AP, que mantiene la responsabilidad.
- **Hospitalización a domicilio**: procesos **agudos** que requerirían ingreso, en el domicilio (antibioterapia IV, reagudización de EPOC). **Alta precoz**: completar la recuperación en casa.
- Momento de **mayor riesgo** para la continuidad: el **alta hospitalaria**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! "Realizar la cura de la UPP" = enfermera de AP. "Coordinar citas, trabajo social y evitar urgencias" = gestora de casos.

A4. Programas de inmovilizados y de pacientes terminales

Inmovilizados

- Dificultad importante o imposibilidad de salir del domicilio (física, psíquica o social); **total** o **parcial**.
- Objetivos: máxima autonomía, prevenir complicaciones (UPP, musculoesqueléticas, respiratorias, estreñimiento), educar y **apoyar al cuidador**.
- Visitas de seguimiento entre **1 al mes y 1 cada 3 meses** si está estable. **Cambios posturales cada 2-3 horas**, superficies especiales, no masajear prominencias. Revisar la polimedicación.
- Alta del programa: recupera la movilidad, traslado, ingreso en residencia, fallecimiento o rechazo.

Pacientes terminales

- Enfermedad avanzada, progresiva e incurable con pronóstico **inferior a 6 meses** (oncológica o no: IC, EPOC, ELA, demencia). Identificación con **NECPAL**.
- Niveles en Murcia: **básico** (EAP, responsable del paciente), **especializado** (equipos de soporte de paliativos y ESAD), **hospitalario** (unidades de paliativos) y **coordinación con urgencias 24 h** (SUAP, PAC, 061).
- Enfermería: dolor con la **escalera analgésica de la OMS**; disnea con oxígeno, **morfina y benzodiacepinas**; **prevenir siempre el estreñimiento con opioides**; cuidados de la boca; curas orientadas al **confort** (no a cicatrizar). Vías: **oral** de elección; si falla, **subcutánea** (nunca intramuscular).
- Ética: consentimiento, instrucciones previas, **adecuación del esfuerzo terapéutico**, **sedación paliativa** (midazolam, ante **síntomas refractarios**) frente a **eutanasia** (provocar la muerte, LO 3/2021).

A5. Informe de Continuidad de Cuidados (ICC)

- Documento médico-legal que transmite la información en **cualquier transición** asistencial (alta, derivación a ESAD o paliativos, traslado, ingreso en residencia, servicios sociales), no solo al alta.
- Contenido: identificación y cuidador, información clínica (**alergias y medicación actualizada**, lo "intocable"), escalas, diagnósticos y plan de cuidados, información social y plan de seguimiento.

- **7 características**: completo, claro, **conciso**, preciso, actualizado, accesible y estandarizado.
- Vía de elección: **historia clínica electrónica**. En el SMS se **autogenera** desde Selene; la enfermera pasa de redactora a **validadora** y añade observaciones.
- **Paciente Crónico Complejo (PCC)**: alerta compartida AP-hospital. **EMAP 2023-2026**: proactividad y liderazgo de la enfermera familiar y comunitaria.

BLOQUE B · Epidemiología y vigilancia epidemiológica

B1. Historia natural de la enfermedad y prevención

- **Leavell y Clark (1958)**: **periodo prepatogénico** (tríada **agente-huésped-medio**) y **patogénico** (**subclínico**, bajo el horizonte clínico, y **clínico**, que acaba en curación, cronicidad, incapacidad o muerte).

Prevención	Actúa en	Objetivo	Ejemplos
Primaria	Prepatogénico	Reducir la **incidencia**	Vacunas, cloración, EpS
Secundaria	Subclínico	Detección precoz; reducir la **prevalencia**	**Cribados**, mamografía, prueba del talón
Terciaria	Clínico	Reducir secuelas, rehabilitar	Rehabilitación
Cuaternaria (Jamoulle, 1986)	Sistema sanitario	Evitar la **sobremedicalización** y la iatrogenia	Desprescribir, evitar pruebas redundantes

- **Epidemiología**: estudio de la **distribución y los determinantes** de los eventos de salud en **poblaciones** y su aplicación al control. Variables de **tiempo, lugar y persona**.
- **Método epidemiológico**: descriptiva → hipótesis → analítica (verificación) → conclusión → nueva hipótesis.
- **Cadena epidemiológica**: **reservorio** (donde vive y se multiplica), **fuente de infección** (de donde pasa al huésped; en la fiebre tifoidea, el reservorio es humano y la fuente, el agua), **mecanismo de transmisión** (directo: contacto, sexual, **gotas de Flügge** < 1 m; indirecto: vehículos, fómites, vectores) y **huésped susceptible**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Una **mamografía de cribado** es prevención **secundaria**, no primaria.

B2. Diseños epidemiológicos

- **Transversal**: prevalencia en un único momento; ambigüedad temporal. **Ecológico**: la unidad es el **grupo**; riesgo de **falacia ecológica**.
- **Sensibilidad** = VP/(VP + FN); **especificidad** = VN/(VN + FP). En cribado en cascada: primero alta sensibilidad, después alta especificidad. Los **valores predictivos** dependen de la prevalencia (el **VPP sube** si sube la prevalencia).
- **Cohortes**: prospectivo, parte de la **exposición**; ideal para exposiciones raras o varios efectos; **RR** (razón de incidencias).
- **Casos y controles**: retrospectivo, parte de la **enfermedad**; ideal para enfermedades **raras**, latencia larga o **brotes**; **OR** = ad/bc. **No se puede calcular el RR**.
- **Ensayo clínico aleatorizado**: manipulación, control y aleatorización. **RRA** = incidencia del control − incidencia del tratado; **NNT = 1/RRA**. **Cuasiexperimental**: intervención sin aleatorización (p. ej., prohibir fumar en una comunidad).

CLAVE PARA RECORDAR

- Enfermedad rara → casos y controles → OR. Exposición rara → cohortes → RR.

B3. Enfermedades transmisibles de mayor incidencia

- **ITS en aumento** (2021-2023): **gonococia +42,6%**, **sífilis +24,1%**, **clamidia** en récord (muy **asintomática** en la mujer: EIP e infertilidad). Más en jóvenes y HSH, por la menor percepción del riesgo (TAR, **PrEP**) y el abandono del preservativo. Guías del Ministerio y SEIMC (Valencia, 2024; horizonte 2030).
- **Infecciones respiratorias**: vigiladas por **SiVIRA** (gripe, COVID-19 y **VRS**). El VRS causa bronquiolitis grave en menores de 1 año (inmunización con **nirsevimab**).
- **Tuberculosis**: descenso lento; amenaza de cepas multirresistentes. Enfermería: **estudio de contactos en círculos concéntricos** y **tratamiento directamente observado**.
- **Campylobacter**: **primera causa de gastroenteritis bacteriana alimentaria** en España (aves de corral, pollo poco cocinado); complicación: **Guillain-Barré**.

B4. RENAVE y Enfermedades de Declaración Obligatoria

- **RENAVE**: creada por el **RD 2210/1995**; coordinada por el **Centro Nacional de Epidemiología** (**ISCIII**). Flujo ascendente: profesional → salud pública de la CA → Ministerio/CNE → **ECDC** → **OMS**. Actualización de la lista: **Orden SSI/445/2015**.
- Vigilancia **pasiva** (espera la declaración), **activa** (busca casos; en alertas y brotes) y **centinela** (muestra de profesionales; p. ej., SiVIRA).
- **Declaración urgente (< 24 h)**, **ante la mera sospecha**, sin esperar al laboratorio: enfermedad meningocócica, **cualquier brote**, legionelosis, Ébola y fiebres hemorrágicas, rabia, cólera, botulismo, carbunco, difteria, fiebre amarilla, tétanos neonatal... **Declaración semanal (ordinaria)**: tuberculosis, VIH/sida, sífilis, clamidia, hepatitis B y C, paludismo...
- **Definición de caso**: **sospechoso** (clínica compatible), **probable** (clínica + **nexo epidemiológico**) y **confirmado** (**laboratorio**).
- **Brote**: **2 o más casos** asociados en tiempo y lugar con una causa común → siempre **urgente**, aunque sea leve.
- **SiViEs**: plataforma informática de la RENAVE (CNE), con anonimización.
- **Murcia**: **Servicio de Epidemiología** (DG de Salud Pública y Adicciones), aplicativo **SIVIET-RM** y Boletín Epidemiológico de Murcia. Desde **2020**: campilobacteriosis, criptosporidiosis, listeriosis, leptospirosis y **dengue como urgente** (por el **mosquito tigre**, *Aedes albopictus*). Vigilancia de **fiebre Q** y leishmaniasis.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Hijo de un caso confirmado de tos ferina que empieza con tos = **caso probable**.
>
> ! 3 casos leves de conjuntivitis en un colegio = **brote** = declaración **urgente**.

B5. SiVIRA, virus emergentes y One Health

- **SiVIRA**: vigilancia centinela todo el año (de la **semana 40 a la 39**); 18 CC. AA. y 49 hospitales (30,5% de la población).
  - **IRA en AP**: inicio en los **últimos 10 días** y al menos uno de: tos, disnea, odinofagia o rinorrea (con o sin fiebre).
  - **IRAG** hospitalaria: requiere ingreso de **al menos 24 h** (o muerte en ese plazo); **sin límite de 10 días**. Muestreo sistemático con PCR múltiple; identificación preferente con el **CIP-SNS**.
- Red centinela de Murcia: más de 120 profesionales. En 2023-2024, las mujeres de 20-59 años consultaron por IRA un **68% más** que los hombres (relacionado con la sobreexposición a los cuidados).
- **Fiebre del Nilo Occidental**: flavivirus transmitido por mosquitos ***Culex***; reservorio en **aves**; humanos y caballos son **fondos de saco** (sin transmisión persona a persona ni aislamiento). **Un caso autóctono = brote**. Muestras de **LCR, suero y orina antes del 5.º día** (PCR e IgM por ELISA). La ONT excluye a donantes que hayan estado en zona activa en los **28 días** previos (salvo PCR negativa y necesidad urgente).
- **Gripe aviar H5N1**: focos en granjas y fauna silvestre; vigilancia de trabajadores expuestos (signo de alarma: **conjuntivitis**); simulacros One Health.
- **Mpox**: *Orthopoxvirus*; contacto **estrecho piel con piel**, fluidos o fómites; **declaración urgente** por SiViEs.

- **One Health**: interdependencia de la salud **humana, animal y ambiental**. **PRAN** (AEMPS y Ministerio de Agricultura): vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comunicación ("Fleming llorando"). Consumo de antibióticos: **−13% en humanos** y **más del −70% en veterinaria**.